

WD87651976585  
H371059114FEC

☒ ACOMPANHAMENTO ( ) CONSULTA

NS J370664671929

**CARLOS ALBERTO ONDAS JUNIOR**

IDADE: 45 PESO: 90,5 ALTURA: 1,71 PROFISSÃO: Analista ADM.

SINTOMAS: Sono leve, diurna; piora memória; déficit concentração

QUEIXAS: Sono; Qualidade sono ruim; Rinite Alérgica; Tosses

MEDICAMENTOS: Citalopram (depressão);

MÉDICO: Dr. Alberto Pimenta

MARCAPASSO: ( ) S ( ) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ( ) S ( ) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 1 à 2x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: 21h30' 23h HORA QUE ACORDA: 05h30' 06h

COCHILO (X) S ( ) N DORME ACOMPANHADO: ( ) S (X) N ( ) EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: ( ) S (X) N / DORMEM NO QUARTO: ( ) S (X) N PET NO QUARTO: (X) S ( ) N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S ( ) X NA SEMANA ( ) N 50 FDS. pouco (Bebida com)

FUMO: ( ) S ( ) MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: parou + de 10 anos tempo

TIPO DE RESPIRAÇÃO: normal BANHEIRO/NOITE: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: S MALLAMPATI: IAH: 57,2 e/h SPO2: 87%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Depressão, Ansiedade (em tratamento medicamentoso).

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Sinal Septo

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

( ) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA ( ) OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S ( ) N SPO2 CI/CPAP: 78% PRESSÃO NO EXAME: 6,0 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 22 e/h (com AC)

28/10/2024. Avaliação \* Comprou Phillips \*

Pressão 6,0 cmH<sub>2</sub>O.

(máscara Dream Weaver (S) - 40 x 60 -  
finha)

06/11 P = 6,0 (7d. de uso)

24 IAH = 9,2 e/h

M. de uso = 6h 16'

fuga = 0,0

Melhora da qualidade sono  
Melhora da rinite  
1X ao banheiro

25/11 P = 6,0 cmH<sub>2</sub>O

24 IAH = 6,8 e/h

M. de uso: 8h

fuga = 0,0 e/h.

Relata melhora do sono.

Just.

15/03 P = 6,0 cmH<sub>2</sub>O

25 IAH = 7,0 e/h

M. de uso: 6h 20'

Bem adaptado.

Relata melhora da rinite.

Just. Cláudia

Bem adaptado  
\* Troco Filtro  
Matecha

31/05/25  $P = 6.0 \text{ cmHg}$   
m. de uso: 8h 10'  
fuga = 2.8 lpm  
IAH = 5.0

ma cábido

|               |  |
|---------------|--|
| IDADE:        |  |
| SINTOMAS:     |  |
| QUEIXAS:      |  |
| MEDICAMENTOS: |  |
| MEDICAMENTOS: |  |
| MARCA:        |  |
| EXERCÍCIO:    |  |
| HORARIO:      |  |
| HORARIO:      |  |
| COCOA:        |  |
| TEMPERATURA:  |  |
| BEBIDAS:      |  |
| FUNÇÃO:       |  |
| TIPICO:       |  |
| CIRCUITO:     |  |
| OVI:          |  |
| PATENTE:      |  |
| CI:           |  |
| HII:          |  |
| CC:           |  |
| PI:           |  |





DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

## LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Carlos Alberto Ondas Junior

EXAME nº: 5529

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 15/11/2023

IDADE: 44 anos

### Comentários:

Exame iniciado às 22h35min e concluído às 05h50min. A latência para o sono foi de 10 minutos e a latência para o estágio REM, de 74 minutos. O tempo total de sono foi de 262,5 minutos (04h22min), com eficiência de sono (TTS/TTR)\* de 61,7%. A distribuição do sono mostrou 21,7% de estágio 1, 46,9% de estágio 2, 19,8% de estágio 3 e 11,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 152,5 minutos em vigília, ocorreram 90 microdespertares (índice: 20,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 3,9/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 57,2/hora, sendo 2,3 apneia/hora e 54,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 66,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 87%.

(\*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

### CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (57,2/hora; índice acentuado acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (66,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 45; máxima: 63 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 10 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (74 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 61,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 20,6/hora; normal até 15/hora) - observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,7%; normal: 8-10%) e 3 (19,8%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (11,6%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (46,9%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (3,9/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 12 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge  
Remesar Lopez  
Médico  
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez  
Diretor Técnico Médica  
CRM-SP 69.730



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

## LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Carlos Alberto Ondas Junior

EXAME nº: 5529-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 07/02/2024

IDADE: 44 anos

### Comentários:

Exame iniciado às 22h11min e concluído às 05h55min. A latência para o sono foi de 9 minutos e a latência para o estágio REM, de 149 minutos. O tempo total de sono foi de 263 minutos (04h23min), com eficiência de sono (TTS/TTR)\* de 56,5%. A distribuição do sono mostrou 29,7% de estágio 1, 41,4% de estágio 2, 11,6% de estágio 3 e 17,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 193 minutos em vigília, ocorreram 103 microdespertares (índice: 23,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 1,4/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 22,6/hora, sendo 2,7 apneia/hora e 19,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 22,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 78%.

(\*) TTS = Tempo Total de Sono      TTR = Tempo Total de Registro

### CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6 cm de H<sub>2</sub>O.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (22,6/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (22,6/hora; ritmo cardíaco sinusal, despertares e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 46; máxima: 62 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 9 min, normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (149 min, normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 56,5%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 23,5/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (29,7%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 2 (41,4%; normal: 45-55%) e REM (17,7%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 3 (11,6%; normal: 10-12%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (1,4/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

PS: observei o aumento de 9 kg do peso corporal desde a data do primeiro exame em 15/11/2023.

Dr. Alberto Remesar Lopez  
Médico  
Pneumologista

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez  
Pneumologista  
CRM-SP 69.739